

PREPARE MON CONCOURS

ConCours 07

QCMs Des Lois 06-22 / 07-22 / 08-22



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

LOI CADRE 06-22

1/ 06-22 pose les principes généraux d'une réforme ou les grandes orientations d'une politique avec une réglementation juridique à suivre dans le domaine de la santé, donc c'est une :

- A/ Loi
- B/ Loi cadre
- C/ Arrêté
- D/ Décret

2/ La présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État dans le domaine de la santé :

- A/ En application des dispositions de l'article 31 de la Constitution.
- B/ En application des dispositions du second alinéa de l'article 52 de la Constitution.
- C/ En application des dispositions de l'article 43 de la Constitution.
- D/ En application des dispositions du second alinéa de l'article 71 de la Constitution.

3/ En exécution de ces Hautes Directives Royales et considérant que le droit à la santé constitue un droit humain fondamental, tel que prévu par :

- A/ Les Pactes internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- B/ La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.
- C/ Les textes réglementaires et la jurisprudence.
- D/ Les Objectifs du Millénaire et la Charte des Nations Unies pour le développement durable.

4/ Loi-cadre n° 06-22 relative au :

- A/ Plan 2025
- B/ Système national de santé
- C/ Groupement Sanitaire Territorial
- D/ Haute Autorité de Santé

5/ Suivant l'Article 2 de cette loi-cadre, les objectifs sont au nombre de :

- A/ 8
- B/ 9
- C/ 10
- D/ 11

6/ Suivant l'Article 2 de cette loi-cadre, l'État œuvre à la réalisation des objectifs suivants :

A/ Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé et améliorer la qualité de ces prestations.

B/ Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé.

C/ Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé.

D/ La privatisation de la fonction sanitaire pour le développement des méthodes managériales innovantes dans les établissements publics de soins.

7/ Au sens de la présente loi-cadre, on entend par Système national de santé :

A/ L'ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aux niveaux national et régional, et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2 ci-dessus.

B/ L'ensemble des dispositifs ou d'unités de soins dont l'objectif est de répondre aux besoins en matière de développement culturel et des enseignements artistiques et spirituels.

C/ Est une force de sécurité intérieure, placée sous l'autorité du ministère de la Santé. Il se divise en plusieurs directions et services, chacun ayant des missions spécifiques.

D/ Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle de PEC sanitaire, et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

8/ Au sens de la présente loi-cadre, on entend par Établissements de santé :

A/ Les divers établissements ou centres de détention ou pénitencier dédiés à l'enfermement de certaines personnes condamnées.

B/ Les divers établissements chargés principalement de l'enseignement et de la recherche dans un champ disciplinaire homogène regroupant des domaines de formation et de connaissance apparentés.

C/ Les divers établissements pour but d'élever, d'instruire les clients indigents ou de familles peu aisées, et les préserver physiquement et moralement des dangers de la misère.

D/ Les divers établissements, quel qu'en soit le régime juridique, organisés dans le but de contribuer à l'offre de soins.

9/ Suivant l'Article 4 de cette loi-cadre, les principes sont au nombre de :

A/ 7

B/ 8

C/ 9

D/ 10

10/ Le système national de santé est basé sur les principes suivants :

A/ La bonne gouvernance.

B/ La mutualisation des moyens.

C/ La non continuité des prestations de santé.

D/ L'adoption de l'approche genre dans l'élaboration des politiques, des programmes et des stratégies de santé.

11/ La réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 ci-dessus est considérée comme une priorité nationale relevant en premier lieu de la responsabilité de :

A/ L'État.

B/ Des collectivités territoriales.

C/ La population.

D/ Les associations.

12/ L'État prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé, notamment ceux relatifs :

A/ Au respect du droit du patient à l'information relative à sa maladie et à la modalité de sa prise en charge.

B/ À la garantie de la protection de l'intégrité physique et morale des personnes.

C/ À la protection de la santé et l'accès aux soins de santé appropriés disponibles.

D/ À l'information de la population sur les risques sanitaires et sur les comportements et les mesures de précaution à adopter pour les prévenir.

13/ L'État veille à la mise en place d'une politique pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du médicament, l'amélioration de sa qualité et la réduction de son prix. Il veille également à la disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. À cet effet, l'État œuvre particulièrement à :

A/ La fixation des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non-médicamenteux et des dispositifs médicaux.

B/ Au renforcement du développement d'une industrie pharmaceutique étrangère et à l'encouragement du développement des médicaments non génériques.

C/ À assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés, sans prendre en considération la garantie, la sécurité et la qualité de ces produits.

D/ À encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires.

14/ L'État œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé :

A/ Par une responsabilité exclusive au ministère de la Santé.

B/ Dans le cadre d'une politique commune, complémentaire et intégrée entre tous les secteurs et en coordination avec l'ensemble des acteurs concernés.

C/ Chaque fois que la vie et la sécurité des individus se trouvent menacées du fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques, l'État prend des mesures d'urgence nécessaires à la protection des individus, en vue de parer aux risques pouvant en résulter.

D/ À la protection des individus seulement sans l'obligation de préserver la santé, et la sécurité des autres : familles, voisins

15/ Toute personne est tenue d'observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dispositions de la présente loi-cadre :

A/ Au cas où une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté, les services publics de santé doivent la soumettre aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées.

B/ Les services publics de santé doivent la transmettre à l'étranger pour une PEC adéquate.

C/ La même mesure peut, le cas échéant, être prise à l'égard des personnes en contact avec elle.

D/ Au cas où une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté, elle peut refuser les soins et les mesures appropriées et se retourner à vivre normalement.

16/ L'offre de soins comporte :

A/ Outre les ressources humaines, l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs public et privé.

B/ Toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles.

C/ Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé.

D/ L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs public et privé et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé.

17/ L'État prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins :

A/ Sur l'ensemble du territoire régional.

B/ Sur l'ensemble du territoire national en fonction des particularités et des besoins de chaque région.

C/ Sur l'ensemble du territoire national.

D/ Sur l'ensemble du territoire préfectoral et provincial.

18/ Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé, le 14 Joumada I 1444 (9 décembre 2022). Fait à :

A/ Marrakech.

B/ Casablanca.

C/ Fès.

D/ Rabat.

19/ Afin de répondre avec efficacité aux besoins de santé par une offre de soins et de prestations complémentaires, intégrées et cohérentes, les secteurs sont organisés par :

A/ Le secteur public.

B/ Le secteur public, que celui-ci soit à but lucratif ou non.

C/ Le secteur privé à but lucratif.

D/ Le secteur privé à but non lucratif.

20/ L'offre de soins est organisée :

A/ Au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire régionale de l'offre de soins.

B/ Dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur privé, ou par un médecin généraliste pour le secteur public.

C/ Au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire nationale de l'offre de soins.

D/ Dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé.

22 / En vue du développement de l'offre de soins :

A / L'État prend les mesures nécessaires pour attirer les compétences des Marocains qui vivent exclusivement au territoire national.

B / L'État prend les mesures nécessaires pour attirer les compétences des Marocains résidant à l'étranger et les compétences étrangères.

C / L'État prend les mesures nécessaires pour attirer les investissements étrangers, de manière à permettre le transfert et le partage des expertises.

D / L'État prend les mesures nécessaires pour attirer les investissements nationaux exclusivement, de manière à permettre le transfert et le partage des expertises.

23 / Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet :

A / Des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation.

B / Ces prestations nécessitent une hospitalisation au sein de l'établissement.

C / Des prestations de prévention et de diagnostic.

D / Que ces prestations nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l'établissement.

24 / L'organisation et la gestion des établissements de santé, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine et des autres professions de santé. En outre, l'organisation et la gestion de ces établissements doivent obéir aux principes, normes et règles ci-après :

- A / Les droits fondamentaux des personnes.
- B / Les normes de sécurité des usagers.
- C / Les normes de sécurité des installations et des équipements.
- D / Les règles d'hygiène et de salubrité.

25 / L'administration établit une carte sanitaire nationale :

- A / Qui détermine les orientations générales de la répartition de l'offre de soins.
- B / Qui détermine les orientations spécifiques de la répartition de l'offre de soins.
- C / Sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante et des données géopolitiques et épidémiologiques au niveau régional.
- D / Sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante et des données géo-démographiques et épidémiologiques au niveau national.

26 / Chaque groupement sanitaire territorial établit :

- A / Dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire régionale.
- B / Dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale.
- C / Une carte sanitaire régionale de l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans le secteur public.
- D / Une carte sanitaire régionale de l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs public et privé.

27 / Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs public et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et les dispositions à même de garantir :

- A / La satisfaction, de manière optimale, des besoins de la population en soins et prestations de santé au niveau régional.
- B / L'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au niveau régional.
- C / La réduction des disparités au sein de la région concernée en matière de l'offre de soins.
- D / L'assurance de la disponibilité du sang et de ses dérivés à l'échelon national.

28 / Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie :

A / Pour une durée indéterminée.

B / Pour une durée déterminée.

C / Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale.

D / Elle ne peut pas être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale.

29 / Selon le Chapitre VI : Partenariat Public-Privé, de cette loi cadre :

A / L'État prend les mesures nécessaires pour instaurer un partenariat entre ces deux secteurs qui prend en considération lesdits spécificités.

B / Les établissements de santé du secteur public peuvent, chaque fois que de besoin, faire appel aux services des professionnels du secteur privé pour accomplir des missions déterminées.

C / Sont également créés des mécanismes spécifiques de coordination des prestations de soins entre les établissements des secteurs public et privé.

D / Encourage le secteur privé à élaborer les politiques de l'État en matière de santé.

30 / En vue d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut qui détermine, en particulier, les garanties fondamentales qui leur sont accordées :

A / Fixé par la loi 09-21.

B / Fixé par la loi 08-21.

C / Fixé par la loi 09-22.

D / Fixé par la loi 08-22.

31 / Le système de formation vise à répondre aux besoins du pays en cadres de santé à travers :

A / Une formation de base développée.

B / Une formation professionnelle spécialisée.

C / La mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues.

D / Un système de formation et de sensibilisation qui vise à développer les compétences individuelles et collectives de la population.

32 / La loi cadre 06-22 vise l'amélioration de la formation, de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé :

A / Les établissements de formation dans le domaine de la santé, relevant des secteurs public, sont chargés des missions de formation de base dans les diverses disciplines.

B / L'État ainsi que les autres organismes publics et privés œuvrent à la prise de toutes les mesures nécessaires à l'encouragement des acteurs concernés à développer des projets de recherche innovants.

C / Les établissements de formation dans le domaine de la santé, relevant des secteurs public et privé, sont chargés des missions de formation de base, de formation spécialisée et de formation continue dans les diverses disciplines.

D / Dans le domaine de la recherche appliquée, le chercheur effectue les travaux de conception et de développement des disciplines : mathématiques, physique, chimie, biologie, médecine, mais aussi psychologie, histoire, sociologie, ethnologie.

33/ En vue d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé il est créé un système :

A/ Information sanitaire nationale intégrée.

B/ Informatique intégrée dénommée « dossier médical partagé ».

C/ Informatique nationale de santé intégrée.

D/ Informatique intégrée dénommée « dossier sanitaire partagé ».

34/ Il est institué un système d'accréditation des établissements de santé :

A/ En vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

B/ En vue de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé par l'élaboration des plans stratégiques et programmes sanitaires.

C/ Vise à porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé ou, le cas échéant, des prestations fournies par un ou plusieurs services relevant de ces établissements.

D/ Sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux établis par la « Haute Autorité de Santé ».

35/ L'État veille à la création des organes de gestion et de gouvernance qui sont :

A/ Haute Autorité de Santé.

B/ Deux établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et des produits de santé et l'autre du sang et de ses dérivés.

C/ Groupements sanitaires territoriaux.

D/ Centre national de surveillance épidémiologique et vigilance sanitaire.

1/ Quelle est la nature juridique de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Une société anonyme à capital public.
- B/ Une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
- C/ Un simple département ministériel.
- D/ Une association à but non lucratif.

2/ Où se trouve le siège de la Haute Autorité ?

- A/ Casablanca.
- B/ Fès.
- C/ Rabat.
- D/ Marrakech.

3/ Selon l'Article 2, dans quels domaines l'Autorité contribue-t-elle à assurer la continuité de l'action de l'État ?

- A/ L'encadrement technique de l'Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO).
- B/ L'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés.
- C/ La gestion directe des hôpitaux publics.
- D/ L'émission d'avis sur les orientations générales et les politiques publiques sanitaires.
- E/ La formulation de propositions et recommandations.

4/ Parmi les missions suivantes, lesquelles relèvent de l'encadrement technique de l'AMO par l'Autorité ?

- A/ Superviser les conventions nationales entre organismes gestionnaires et prestataires de soins.
- B/ Arbitrer les litiges entre intervenants.
- C/ Fixer elle-même le montant des cotisations AMO.
- D/ Veiller à l'équilibre financier global des régimes.
- E/ Normaliser les outils de gestion de l'AMO.

5/ Parmi les missions suivantes, lesquelles font partie des « autres missions principales » de l'Autorité

- A/ L'accréditation des établissements de santé publics et privés.
- B/ Le suivi et l'analyse des données épidémiologiques.
- C/ La nomination des ministres de la Santé.
- D/ La médiation dans les litiges soumis par les professionnels de santé.
- E/ L'évaluation périodique des médicaments, produits de santé et actes professionnels.

6/ Que peut faire l'Autorité concernant les textes législatifs ou réglementaires, selon l'Article 4 ?

- A/ Les adopter directement sans passer par le Parlement.
- B/ Proposer des projets de textes et émettre un avis consultatif sur ceux soumis par le gouvernement.
- C/ Les annuler si elle les juge inadéquats.
- D/ Aucune de ces réponses.

7/ Concernant les délais de médiation prévus à l'Article 8, lesquelles de ces affirmations sont exactes

- A/ Le délai maximum est de 60 jours.
- B/ Le délai maximum est de 90 jours.
- C/ Le délai peut être réduit à 20 jours en cas d'urgence.
- D/ Il n'existe aucun délai fixé par la loi.
- E/ Le délai réduit s'applique uniquement aux litiges financiers.

8/ À qui l'Autorité doit-elle soumettre son rapport annuel d'activités, selon l'Article 10 ?

- A/ Uniquement au Chef du Gouvernement.
- B/ Uniquement au Parlement.
- C/ À Sa Majesté le Roi, au Chef du Gouvernement et au Parlement.
- D/ Uniquement à la Cour des Comptes.

9/ Avant quelle date le rapport annuel d'activités doit-il être soumis ?

- A/ Avant fin janvier.
- B/ Avant fin mars.
- C/ Avant fin juin.
- D/ Avant fin décembre.

10/ De quels organes se composent les organes de l'Autorité selon l'Article 11 ?

- A/ Un Conseil.
- B/ Un Président.
- C/ Une Assemblée Générale.
- D/ Un Comité de Direction.

11/ Selon l'Article 12, quelle est la composition du Conseil ?

- A/ Un Président.
- B/ 5 membres permanents.
- C/ 10 membres conseillers (experts santé, juridique, économique).
- D/ 3 représentants syndicaux.
- E/ 2 représentants du Parlement.

12/Concernant le mandat des membres du Conseil (Articles 13 à 17), lesquelles de ces affirmations sont correctes ?

- A/ Le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois.
- B/ Le mandat est incompatible avec des mandats électifs.
- C/ Le mandat est incompatible avec des intérêts dans le secteur de la santé.
- D/ Les membres permanents exercent leur fonction à temps partiel.
- E/ Les membres sont soumis à une obligation de réserve.

13/ Quels pouvoirs le Conseil détient-il selon l'Article 19 ?

- A/ Validation des programmes.
- B/ Validation du budget.
- C/ Validation des statuts et accréditations.
- D/ Validation des partenariats.
- E/ Nomination directe du Président.

14/ Que fait le Président de l'Autorité selon les Articles 21 à 23 ?

- A/ Il gère l'Autorité.
- B/ Il préside le Conseil.
- C/ Il représente l'institution.
- D/ Il est assisté d'un Secrétaire Général.
- E/ Il nomme seul tous les membres du Conseil.

15/ Quel est le rôle du Comité Scientifique créé par l'Article 24 ?

- A/ Gérer le budget de l'Autorité.
- B/ Assurer le suivi des crises, des études et des nouveautés scientifiques.
- C/ Remplacer le Conseil en cas d'absence du Président.
- D/ Représenter l'Autorité à l'international.

15/ Quel est le rôle du Comité Scientifique créé par l'Article 24 ?

- A/ Gérer le budget de l'Autorité.
- B/ Assurer le suivi des crises, des études et des nouveautés scientifiques.
- C/ Remplacer le Conseil en cas d'absence du Président.
- D/ Représenter l'Autorité à l'international.

16/ Comment le budget de l'Autorité est-il composé, selon l'Article 25 ?

- A/ De subventions de l'État.
- B/ D'un prélèvement unifié sur les cotisations AMO.
- C/ De dons de particuliers uniquement.
- D/ De recettes fiscales directes.

17/ Qui assure le contrôle financier de l'Autorité selon l'Article 26 ?

- A/ Un comptable public.
- B/ La Cour des Comptes.
- C/ Le Ministère de l'Intérieur.
- D/ Une société d'audit privée.

18/ Selon l'Article 28, de qui le personnel de l'Autorité est-il constitué ?

- A/ D'agents statutaires.
- B/ De fonctionnaires détachés.
- C/ D'experts contractuels.
- D/ Uniquement de fonctionnaires titulaires du Ministère de la Santé.

19/ Concernant le transfert prévu par les Articles 29 à 34, lesquelles de ces affirmations sont exactes

- A/ Le personnel de l'ANAM est transféré automatiquement vers la Haute Autorité.
- B/ Le personnel transféré conserve ses acquis.
- C/ Les biens, archives, droits et obligations de l'ANAM sont transférés à la nouvelle Autorité.
- D/ Le personnel de l'ANAM doit repasser un concours pour intégrer la nouvelle Autorité.

20/ Que prévoit l'Article 35 ?

- A/ La suppression pure et simple de l'ANAM sans transfert de dénomination.
- B/ La substitution de la dénomination « Haute Autorité de la Santé » à « ANAM » dans les textes en vigueur.
- C/ Le maintien du nom « ANAM » dans tous les textes.
- D/ La création d'une troisième entité distincte.

21/ Selon l'Article 36, dans quel délai maximum l'entrée en vigueur doit-elle intervenir après publication des textes réglementaires ?

- A/ 3 mois.
- B/ 6 mois.
- C/ 12 mois.
- D/ 24 mois.

22/ Quel est le texte de loi qui régit la création de la Haute Autorité de Santé ?

- A/ Loi n° 08.22.
- B/ Loi n° 07.22.
- C/ Loi n° 06.22.
- D/ Loi n° 05.22.

23/ Qu'est-ce que désigne l'expression « Haute Autorité de Santé » dans la loi 07-22 ?

- A/ Une personne physique ayant une expertise en matière de santé.
- B/ Une organisation non gouvernementale travaillant dans le domaine de la santé.
- C/ Une personne morale de droit public jouissant de l'autonomie financière.
- D/ Un organisme international de santé.

24/ Quel est le rôle de la Haute Autorité de Santé (HAS) ?

- A/ Elle donne son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé.
- B/ Elle assure la promotion de la santé publique.
- C/ Elle évalue la qualité des services des établissements de santé dans les secteurs public et privé.
- D/ Elle assume la tâche de contrôle technique de l'Assurance Maladie Obligatoire de base.

25/ Que peut faire la Haute Autorité de Santé dans le cadre d'échanges d'expériences ?

- A/ Conclure des contrats avec des acteurs de tout domaine.
- B/ Conclure des conventions de partenariat avec des acteurs internationaux.
- C/ Conclure des contrats ou conventions de partenariat avec des acteurs internationaux relevant de son domaine de compétence.
- D/ Conclure des contrats ou conventions de partenariat avec des acteurs locaux relevant de son domaine de compétence.

26/ Quelle est la durée maximale pour que la Haute Autorité de Santé statue sur les demandes de conciliation ?

- A/ 30 jours à compter de la date de constitution du dossier de candidature.
- B/ 60 jours à compter de la date de constitution du dossier de candidature.
- C/ 90 jours à compter de la date de constitution du dossier de candidature.
- D/ 120 jours à compter de la date de constitution du dossier de candidature.

27/ Dans quel cas le délai maximum de 90 jours pour statuer sur les demandes de conciliation est-il ramené à 20 jours ?

- A/ Si l'Autorité est en période de congé.
- B/ Si les demandeurs susvisés ont payé des frais supplémentaires.
- C/ Si l'état d'urgence et ses motifs sont invoqués par les demandeurs susvisés.
- D/ Si les demandes de conciliation sont jugées non prioritaires.

28/ Quand l'Autorité prépare-t-elle son rapport annuel ?

- A/ Avant la fin du mois de décembre de chaque année.
- B/ Avant la fin du mois de mars de chaque année.
- C/ Avant la fin du mois de juin de chaque année.
- D/ Il n'y a pas de date précise pour la préparation du rapport annuel.

29/ Combien de membres composent le Conseil de la Haute Autorité de Santé (HAS), en plus du Président ?

- A/ 5 membres permanents et 10 membres consultatifs.
- B/ 10 membres permanents et 5 membres consultatifs.
- C/ 5 membres permanents et 5 membres consultatifs.
- D/ 10 membres permanents et 10 membres consultatifs.

30/ Les membres du Conseil, y compris le Président, sont nommés pour une durée de :

- A/ Deux (2) ans, renouvelable deux fois.
- B/ Cinq (5) ans, renouvelable une fois.
- C/ Trois (3) ans, renouvelable trois fois.
- D/ Quatre (4) ans, non renouvelable.

31/ Dans quels cas les fonctions des membres du Conseil prennent-elles fin ?

- A/ Perte de jouissance des droits civils et politiques.
- B/ La survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement le membre d'exercer ses fonctions.
- C/ À l'expiration du mandat.
- D/ Par le décès du membre.

32/ Le Conseil de la HAS dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, qui sont :

- A/ Établir le programme annuel des activités de l'Autorité.
- B/ Approuver les statuts des salariés de l'Autorité.
- C/ Déterminer le budget annuel de l'Autorité.
- D/ Toutes les réponses sont justes.

33/ À quelle fréquence le Conseil de la HAS se réunit-il ?

- A/ Au moins une fois par an.
- B/ Au moins trois fois par an.
- C/ Au moins deux fois par an.
- D/ Au moins quatre fois par an.

34/ Le budget de l'Autorité comprend, dans la rubrique des ressources :

- A/ Les subventions accordées par l'État, le cas échéant.
- B/ Les revenus des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Autorité.
- C/ Les revenus liés à ses activités.
- D/ Les dons et legs.

35/ Le budget de l'Autorité comprend, dans la rubrique des dépenses :

- A/ Les dépenses de fonctionnement.
- B/ Les dépenses d'équipement et d'investissement.
- C/ Les autres dépenses liées aux tâches confiées à l'Autorité.
- D/ Toutes les réponses ne sont pas correctes.

36/ Quel est le rôle de l'organe de contrôle interne au sein de l'Autorité ?

- A/ Il est chargé de conclure des conventions de partenariat avec des acteurs internationaux.
- B/ Il informe régulièrement le Président du Conseil des résultats de ses travaux.
- C/ Il est chargé de contrôler la conformité des différents intérêts de l'Autorité aux normes et procédures liées à ses activités.
- D/ Il présente un rapport sur sa mission à chaque réunion du Conseil.

37/ Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'Autorité dispose de moyens humains constitués comme suit :

- A/ Les salariés employés conformément aux statuts des salariés de l'Autorité.
- B/ Les salariés qui lui sont rattachés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- C/ Les salariés mis à sa disposition malgré toutes dispositions contraires.
- D/ Des experts engagés sous contrat pour l'exécution de tâches spécifiques et pour une durée indéterminée.

38/ Que se passe-t-il pour les fonctionnaires, stagiaires et vacataires travaillant pour l'Agence nationale d'Assurance Maladie ?

- A/ Ils doivent postuler pour travailler à l'Autorité.
- B/ Ils sont transférés de plein droit à l'Autorité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- C/ Leur contrat est annulé.
- D/ Ils sont affectés à d'autres services.

39/ Quels sont les documents que la Haute Autorité de la Santé doit fournir lors des réunions du conseil ?

- A/ Un rapport financier.
- B/ Un rapport sur les activités.
- C/ Un rapport sur les partenariats internationaux.
- D/ Aucun document n'est requis.

40/ Quel est le délai maximum pour que la Haute Autorité de la Santé publie son rapport annuel ?

- A/ 31 janvier.
- B/ 31 mars.
- C/ 30 juin.
- D/ 31 décembre.

41/ Dans quel cas la Haute Autorité de la Santé peut-elle proposer des modifications législatives ?

- A/ En cas de changement de gouvernement.
- B/ À la demande du Parlement.
- C/ À la demande du gouvernement.
- D/ De sa propre initiative.

42/ Qui est responsable de la validation des conventions internationales entre la Haute Autorité de la Santé et les prestataires de soins ?

- A/ Le président de la Haute Autorité.
- B/ Le conseil de la Haute Autorité.
- C/ Le ministre de la Santé.
- D/ Le Premier ministre.

43/ Quelle est la durée maximale de renouvellement du mandat des membres du conseil de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Un mandat.
- B/ Deux mandats.
- C/ Trois mandats.
- D/ Quatre mandats.

44/ Qui a le droit d'assister aux réunions du conseil de la Haute Autorité de la Santé avec une voix consultative ?

- A/ Le Président de la République.
- B/ Un représentant des associations de patients.
- C/ Le délégué du gouvernement.
- D/ Tout membre du personnel administratif.

45/ Quels sont les outils que la Haute Autorité de la Santé peut utiliser pour surveiller les systèmes d'assurance maladie ?

- A/ Les outils financiers.
- B/ Les outils statistiques.
- C/ Les audits de performance.
- D/ Les partenariats publics-privés.

46/ La Haute Autorité de la Santé peut-elle imposer des sanctions aux établissements de santé ?

A/ Oui.

B/ Non.

47/ Quels types d'établissements de santé peuvent être accrédités par la Haute Autorité de la Santé ?

A/ Les établissements publics uniquement.

B/ Les établissements privés uniquement.

C/ Les établissements publics et privés.

D/ Les cliniques spécialisées uniquement.

48/ Quelle est la fréquence minimale d'évaluation des médicaments par la Haute Autorité de la Santé ?

A/ Tous les mois.

B/ Tous les six mois.

C/ Tous les ans.

D/ Tous les deux ans.

49/ Comment la Haute Autorité de la Santé assure-t-elle la transparence de ses décisions ?

A/ Par la publication de rapports annuels.

B/ Par des communiqués de presse.

C/ Par des séances publiques.

D/ Par la soumission de rapports au Parlement.

50/ Qui est chargé de l'audit interne de la Haute Autorité de la Santé ?

A/ Un auditeur externe.

B/ Le conseil de la Haute Autorité.

C/ Un organe d'audit interne.

D/ Le Ministère de la Santé.

51/ Quels types de recommandations peut émettre la Haute Autorité de la Santé ?

A/ Recommandations cliniques.

B/ Recommandations politiques.

C/ Recommandations financières.

D/ Recommandations éducatives.

52/ Quel est le rôle du comité scientifique au sein de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Suivre les crises sanitaires.
- B/ Proposer des mesures correctives.
- C/ Mener des études de marché.
- D/ Fournir un soutien aux professionnels de la santé.

53/ Comment est structuré le financement de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Subventions de l'État.
- B/ Cotisations des assurés.
- C/ Revenus des activités.
- D/ Fonds privés.

54/ Quels sont les pouvoirs du président de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Définir le budget annuel.
- B/ Licencier les membres du conseil.
- C/ Représenter l'Autorité devant les tribunaux.
- D/ Déterminer les orientations politiques.

55/ Qui peut demander un audit externe de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Le Président de la Haute Autorité.
- B/ Le Ministre de la Santé.
- C/ Le Parlement.
- D/ Le Premier ministre.

56/ Comment sont nommés les membres du conseil de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Par le Président de la République.
- B/ Par le Ministre de la Santé.
- C/ Par le Conseil d'État.
- D/ Par décret.

57/ Quel est le champ d'application des recommandations de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ National uniquement.
- B/ International.
- C/ Local et régional.
- D/ Tous les choix ci-dessus.

58/ Quels sont les éléments examinés par la Haute Autorité de la Santé lors de l'évaluation des services de santé ?

- A/ L'efficacité des soins.
- B/ Le coût des services.
- C/ La satisfaction des patients.
- D/ La conformité aux normes de sécurité.

59/ Quelle est la mission principale de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Assurer le financement des hôpitaux publics.
- B/ Assurer l'évaluation et l'amélioration de la qualité des soins.
- C/ Organiser des événements scientifiques.
- D/ Superviser la formation continue des professionnels de santé.

60/ Combien de membres composent le conseil de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ 5 membres.
- B/ 10 membres.
- C/ 15 membres.
- D/ 20 membres.

61/ Quelle est la durée du mandat des membres du conseil de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ 3 ans.
- B/ 5 ans.
- C/ 7 ans.
- D/ 10 ans.

62/ Qui nomme le président de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Le Ministère de la Santé.
- B/ Le Premier ministre.
- C/ Le Roi.
- D/ Le Parlement.

63/ Quel est le rôle de la Haute Autorité de la Santé dans le domaine de l'Assurance Maladie Obligatoire ?

- A/ Définir les taux de cotisation.
- B/ Superviser les négociations pour les conventions nationales.
- C/ Émettre des obligations de financement.
- D/ Promouvoir l'utilisation des médicaments génériques.

64/ La Haute Autorité de la Santé peut-elle proposer des textes législatifs ou réglementaires ?

- A/ Oui.
- B/ Non.

65/ Quels types d'accords peut signer la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Partenariats internationaux uniquement.
- B/ Partenariats locaux uniquement.
- C/ Partenariats locaux et internationaux.
- D/ Aucun.

66/ Combien de fois par an le conseil de la Haute Autorité de la Santé doit-il se réunir au minimum ?

- A/ Une fois.
- B/ Deux fois.
- C/ Trois fois.
- D/ Quatre fois.

67/ Quel est le rôle du directeur général de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Représenter l'institution devant la justice.
- B/ Fixer les salaires des employés.
- C/ Organiser les réunions du conseil.
- D/ Gérer les ressources financières de l'Autorité.

68/ La Haute Autorité de la Santé est-elle autorisée à réaliser des études et recherches ?

- A/ Oui, en toute autonomie.
- B/ Oui, mais uniquement à la demande du gouvernement.
- C/ Non, cela n'est pas de son ressort.

69/ Quel type de structure est la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Une entreprise publique.
- B/ Un établissement public à caractère administratif.
- C/ Une ONG.
- D/ Une organisation privée.

70/ Quel document doit être soumis par la Haute Autorité de la Santé avant le 31 mars de chaque année ?

- A/ Le budget annuel.
- B/ Un rapport annuel sur ses activités.
- C/ Un plan quinquennal de développement.
- D/ Un bilan financier.

71/ Qui peut demander l'avis de la Haute Autorité de la Santé sur des projets de loi ou de règlement

- A/ Le Président de la République.
- B/ Le gouvernement.
- C/ Le Parlement.
- D/ Les deux.

72/ Quel est le rôle de la Haute Autorité de la Santé dans la gestion des crises sanitaires ?

- A/ Suivre les crises sanitaires et proposer des mesures adéquates.
- B/ Fournir un soutien financier aux hôpitaux.
- C/ Évaluer les services hospitaliers.
- D/ Promouvoir des campagnes de sensibilisation.

73/ Quels critères la Haute Autorité de la Santé utilise-t-elle pour accréditer les établissements de santé ?

- A/ Critères financiers uniquement.
- B/ Critères de performance clinique.
- C/ Critères de qualité des soins.
- D/ Critères de satisfaction des patients.

74/ Quels sont les domaines d'intervention de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Assurance maladie obligatoire.
- B/ Politique de santé publique.
- C/ Promotion de l'hygiène.
- D/ Construction d'hôpitaux.

75/ Quel est l'un des objectifs de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Améliorer l'accès aux soins pour tous.
- B/ Limiter le budget des hôpitaux.
- C/ Réduire les coûts administratifs.
- D/ Supprimer les hôpitaux privés.

76/ Comment est financée la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Par les cotisations sociales.
- B/ Par le budget de l'État.
- C/ Par des dons privés.
- D/ Par les recettes de services rendus.

77/ Qui a le pouvoir de dissoudre le conseil de la Haute Autorité de la Santé ?

- A/ Le Premier ministre.
- B/ Le Président de la République.
- C/ Le Parlement.
- D/ Aucun des choix.

LOI 08-22

1/ Que vise le projet de loi n° 08.22 ?

- A/ La création de nouveaux hôpitaux dans les régions.
- B/ La création de centres de soins pour les personnes âgées.
- C/ La création de groupements territoriaux de santé.
- D/ La création de centres de recherche en santé.

2/ Quelles sont les sources de revenus énumérées dans la rubrique ressources de GST ?

- A/ Les revenus de ses activités.
- B/ Les revenus de fonds mobiliers et immobiliers.
- C/ Les subventions de l'État.
- D/ Dons et legs.

3/ Quels types de dépenses sont inclus dans la rubrique « dépenses de GST » ?

- A/ Dépenses d'investissement.
- B/ Dépenses de fonctionnement.
- C/ Rembourser les avances et emprunts.
- D/ Les dépenses liées à tout organisme soumis au droit public ou privé.

4/ Quel est l'objectif de la fusion du CHU et de l'ensemble des unités hospitalières régionales en un seul établissement public indépendant chargé des soins hospitaliers dans le cadre de GST ?

- A/ Réduire le nombre de patients hospitalisés.
- B/ Améliorer la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux.
- C/ Réorganiser la gouvernance du système national de santé.
- D/ De rappeler les choix stratégiques inscrits dans le rapport général sur le modèle de développement.

5/ Quels sont les projets préparés par le directeur général de GST, pour approbation au conseil d'administration ?

- A/ Les projets de développement durable.
- B/ Le budget annuel du groupe.
- C/ Programme médical régional.
- D/ Le plan de travail annuel du groupe.

6/ Parmi les attributions du directeur général de GST, on peut citer :

- A/ Exécuter les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, les décisions des comités créés par ce dernier.
- B/ Préparer les projets qui sont présentés au conseil d'administration pour approbation.
- C/ Gérer l'ensemble des structures du groupe et des établissements de santé qui le composent et coordonner leurs activités.
- D/ Accomplir ou autoriser tout acte ou action en rapport avec les tâches du groupe.

7/ Qui peut être considéré comme faisant partie du personnel du groupe GST ?

- A/ Les fonctionnaires et personnels transférés au groupe conformément aux statuts de son personnel.
- B/ Les fonctionnaires rattachés au groupe conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- C/ Les personnels recrutés conformément aux statuts des personnels du groupe.
- D/ Les retraités qui ont travaillé pour le groupe par le passé.

8/ Combien de temps les experts mandatés par le groupement peuvent-ils réaliser des missions ?

- A/ Indéfiniment.
- B/ Pour une période de temps spécifique.
- C/ Pour une période de temps qui dépend de leur disponibilité.
- D/ Pour une période de temps qui dépend des résultats obtenus.

9/ Qui est automatiquement transféré au GST ?

- A/ Tous les fonctionnaires travaillant pour le Ministère de la Santé.
- B/ Les fonctionnaires titulaires et les stagiaires travaillant dans les services centraux du Ministère de la Santé.
- C/ Les fonctionnaires titulaires et les stagiaires travaillant dans les services déconcentrés du Ministère de la Santé situés en dehors de l'emprise territoriale de GST.
- D/ Les fonctionnaires titulaires et les stagiaires travaillant dans les services déconcentrés du Ministère de la Santé situés dans l'emprise territoriale de GST.

10/ Quel est le but principal des efforts déployés par le pays dans le domaine de la santé ?

- A/ Répondre aux besoins croissants en matière de transport sanitaire.
- B/ Répondre aux besoins sanitaires croissants des citoyens et citoyennes.
- C/ Promouvoir l'exportation des médicaments et des produits pharmaceutiques.
- D/ Toutes les réponses sont justes.

11/ Quel est le nom sous lequel s'exprime l'organisation dans les différentes régions du Royaume ?

- A/ Le Groupement sanitaire territorial.
- B/ Le Conseil régional de santé.
- C/ L'Association des médecins locaux.
- D/ La Fédération des hôpitaux régionaux.

12/ Quels sont les attributs du Groupement sanitaire territorial ?

- A/ La personnalité politique et l'autonomie administrative.
- B/ La personnalité morale et l'autonomie financière.
- C/ La subordination au gouvernement central et la tutelle financière.
- D/ La responsabilité de la gestion des établissements de santé locaux.

13/ Quelle est la mission de l'État envers le Groupement sanitaire territorial ?

- A/ Assurer l'exécution des textes réglementaires y afférents.
- B/ Ignorer les missions dévolues au groupement.
- C/ Contrôler la gestion financière de l'entreprise.
- D/ Aucune réponse n'est juste.

14/ Comment le groupement est-il soumis au contrôle financier de l'État ?

- A/ Selon les dispositions de la loi organique.
- B/ En utilisant ses organes compétents.
- C/ Conformément aux textes législatifs en vigueur pour les établissements publics.
- D/ Sans contrôle financier du tout.

15/ Quels établissements ne font pas partie du Groupement sanitaire territorial décrit dans le projet de loi 08-22 ?

- A/ Les établissements de santé affiliés à son influence territoriale.
- B/ Les établissements de santé soumis à des textes législatifs ou réglementaires particuliers.
- C/ Les établissements hospitaliers militaires.
- D/ Les bureaux municipaux d'hygiène.

16/ Quelle est la mission principale du Groupement sanitaire territorial en matière de santé ?

- A/ Assurer la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé.
- B/ Fournir des services financiers pour les professionnels de la santé.
- C/ Contrôler les services de santé à l'échelle nationale.
- D/ Gérer les infrastructures de santé publiques.

17/ Quels sont les domaines de compétence du Groupement sanitaire territorial (GST) ?

- A/ Le domaine de l'offre de services.
- B/ Le domaine de la formation.
- C/ Le domaine de la santé publique.
- D/ Le domaine de la recherche, de l'expertise et de l'innovation.

18/ Quelles sont les tâches confiées au GST dans le domaine de l'offre de soins ?

- A/ Création de nouveaux établissements de santé selon la carte sanitaire régionale.
- B/ Organiser la filière et le parcours de soins de façon harmonisée au sein des établissements de santé qui lui sont affiliés.
- C/ Élaboration et mise à jour de la carte sanitaire régionale selon les orientations générales précisées dans la carte sanitaire nationale.
- D/ Élaboration et mise en œuvre d'un programme médical régional.

19/ Quel est l'objectif du programme médical régional évoqué dans la loi n° 08-22 ?

- A/ La synergie dans l'utilisation des ressources disponibles.
- B/ Harmoniser les pratiques médicales à l'échelle nationale.
- C/ Renforcer l'offre de soins en tenant compte des spécificités régionales.
- D/ Assurer la progressivité et la continuité des soins entre les différentes filières et niveaux de soins.

20/ Quel est le texte de loi qui régit la création des Groupements sanitaires territoriaux ?

- A/ Loi n° 08.22.
- B/ Loi n° 07.22.
- C/ Loi n° 06.22.
- D/ Loi n° 05.22.

21/ Quelles sont les tâches du Groupement sanitaire territorial (GST) dans le domaine de la santé publique ?

- A/ Assurer l'éducation sanitaire des personnes dépendantes et encourager l'éducation thérapeutique.
- B/ Réaliser l'organisation et le contrôle médical des urgences hospitalières.
- C/ Veiller à la protection de la santé publique, assurer la vigilance sanitaire et organiser la surveillance des épidémies.
- D/ Toutes les réponses sont justes.

22/ Quels sont les types de soins que le GST fournit ?

- A/ Prendre des mesures visant à assurer la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge.
- B/ Des services de réadaptation uniquement.
- C/ Des services de diagnostic, de traitement et de réadaptation, avec ou sans hébergement.
- D/ Des services de réadaptation pour les personnes âgées uniquement.

23/ Quelle est la mission du GST dans le domaine de la formation ?

- A/ Assurer la formation pratique de base des étudiants en médecine, pharmacie et dentisterie du secteur public.
- B/ Fournir des soins médicaux aux patients.
- C/ Organiser des événements culturels.
- D/ Assurer la formation appliquée des étudiants en formation professionnelle dans les métiers de la santé.

24/ Quelle(s) tâche(s) fait le GST dans le domaine de la recherche, de l'expertise et de l'innovation ?

- A/ Réalisation d'expertises médico-légales, biomédicales et techniques.
- B/ Contribuer à l'évaluation de la technologie médicale.
- C/ Mettre en place des pôles d'excellence et des centres de référence au sein de ses établissements de santé affiliés.
- D/ Exploiter tout brevet ou invention dans le domaine de la santé.

25/ Quelles professions ou activités le GST autorise-t-il dans le secteur privé ?

- A/ Professeur d'université.
- B/ Professions infirmières.
- C/ Profession de sage-femme.
- D/ Création et exploitation des établissements de santé.

26/ Le GST est chargé d'encourager les relations de coopération avec les acteurs du domaine de la santé au niveau :

- A/ National.
- B/ Régional.
- C/ International.
- D/ Tous les niveaux.

27/ Quels sont les acteurs avec lesquels le GST doit encourager les relations de coopération au niveau régional ?

- A/ Les administrations publiques.
- B/ Les collectivités territoriales.
- C/ Le secteur privé.
- D/ La société civile.

28/ Quelle est la principale fonction du GST dans le domaine administratif ?

- A/ Assurer la disponibilité des médicaments et produits de santé dans les établissements de santé au niveau national.
- B/ Évaluer la performance des établissements de santé qui le composent.
- C/ Coordonner les activités des établissements de santé qui composent le groupe sanitaire.
- D/ Contribuer au contrôle et à l'inspection financière, administrative et médicale des établissements de santé qui le composent.

29/ Quel est le rôle du GST dans la gestion des médicaments et produits de santé ?

- A/ Assurer la disponibilité des médicaments et produits de santé dans les pharmacies nationales.
- B/ Assurer la disponibilité des médicaments et produits de santé au sein des établissements de santé qui composent le groupe.
- C/ Faciliter l'accès aux médicaments et produits de santé au niveau des établissements de santé qui composent le groupe.
- D/ Distribuer directement les médicaments et produits de santé aux patients.

30/ Quelle est la tâche principale du GST en matière de partenariat avec le secteur privé de la santé

- A/ Organiser des formations conjointes avec les établissements privés de santé.
- B/ Établir des conventions de partenariat avec les établissements privés de santé.
- C/ Contrôler les activités des établissements privés de santé.
- D/ Évaluer la performance des établissements privés de santé.

31/ Qui est responsable de la direction stratégique du GST ?

- A/ Le directeur régional.
- B/ Le conseil d'administration.
- C/ Le directeur de l'hôpital.
- D/ Le directeur général.

32/ Qui est responsable de la gestion du GST ?

- A/ Le directeur régional.
- B/ Le conseil d'administration.
- C/ Le directeur de l'hôpital.
- D/ Le directeur général.

33/ Parmi les membres du conseil d'administration du GST figurent :

- A/ Des représentants des services concernés définis par un texte réglementaire.
- B/ Le président du Conseil de la région ou son représentant.
- C/ Le wali de la région ou son représentant.
- D/ Trois membres indépendants ayant une expérience dans les domaines de la santé.

34/ Parmi les attributions du conseil d'administration du GST, on trouve :

- A/ Approbation du programme de travail annuel du groupe.
- B/ Adoption de la carte sanitaire régionale, selon les orientations générales précisées dans la carte sanitaire nationale.
- C/ Adoption du programme médical régional.
- D/ Toutes les réponses sont fausses.

35/ Quel est l'engagement du conseil d'administration en matière de comité spécialisé d'audit ?

- A/ Nommer un seul membre pour le comité.
- B/ Déterminer sa composition et son fonctionnement.
- C/ Confier cette tâche à un organisme externe.
- D/ Ne pas intervenir dans la constitution du comité.

36/ Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire :

- A/ Une fois par an.
- B/ Tous les trimestres.
- C/ Au moins deux fois par an.
- D/ Tous les mois.

37/ Quelles sont les principales raisons pour lesquelles le conseil d'administration se réunit ?

- A/ Pour le suivi de l'exécution de ses décisions.
- B/ Pour discuter du programme prévisionnel et du budget de l'année suivante.
- C/ Pour dresser un bilan des réalisations passées.
- D/ Pour discuter de problèmes personnels des membres du conseil d'administration et élaborer des listes de souhaits pour l'année prochaine.

38/ Quel est le quorum requis pour que les délibérations du conseil d'administration soient valables

- A/ Le tiers de ses membres présents ou représentés.
- B/ La moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants.
- C/ Les deux tiers de ses membres présents ou représentés.
- D/ La totalité de ses membres présents ou représentés.

39/ Que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion du conseil d'administration ?

- A/ Les délibérations sont annulées et reportées à une date ultérieure.
- B/ Une seconde réunion est convoquée dans un délai d'au moins huit jours.
- C/ La deuxième réunion est valablement tenue quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
- D/ La première réunion est prolongée jusqu'à ce que le quorum soit atteint.

40/ Comment est nommé le directeur général du groupe ?

- A/ Par le conseil d'administration.
- B/ Par les actionnaires majoritaires.
- C/ Selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- D/ Par les employés du groupe.